



1

55. ÅRGANG | 01 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Tema

Angst

PPT nr. 1-2018

**Behandling af et barn med
angst og trods**

*Af Mette Maria Agner Pedersen og
Barbara Hoff Esbjørn*

Behandling af et barn med angst og trods

Et pragmatisk casestudie af Max og hans forældre



Artiklen er et pragmatisk casestudie af Max og hans forældre, der har fokus på forældreadfærd hos forældre til et barn med komorbid angst og trodsforstyrrelse (ODD). Artiklen ser på, hvilke former for forældreadfærd der ses ved både angst og ODD. Den stiller skarpt på de mekanismer forskere har fundet i tidligere studier og viser gennem casestudiet, hvordan forældre spiller ind i behandling af barnet. Formålet med artiklen er at videregive praksisnær viden om, hvordan professionelle kan forstå og arbejde med familier, hvor barnet lider af komorbid angst og ODD.

*Af Mette Maria Agner Pedersen, cand.psych. og
Barbara Hoff Esbjørn, professor mso og leder af Center for Angst,
Københavns Universitet*

Komorbiditeten mellem angst og ODD ses ofte hos børn (Angold, Costello & Erkanli, 1999). Op mod 9,2% af angste børn opfylder kriterierne for ODD (Kendall, Brady & Verduin, 2001). Behandling af ODD indebærer, at forældre lærer tydelig grænsesætning, konsistent opdragelse og reinforcement af ønsket adfærd (Hood, Elrod & DeWine, 2015). Modsat disse programmer, der har god effekt, ses ingen mereffekt ved inddragelse af forældre i behandling af angste børn (Breinholst et al., 2012). Dette efterlader spørgsmålet om, hvorvidt forældreinddragelse bliver nødvendig ved behandling af komorbid angst og ODD. Artiklen er derfor et casestudie af, hvordan forældre-barn samspillet er relateret til barnets vanskeligheder, og hvordan forældre kan inddrages i et behandlingsforløb.

Teoretisk forståelsesramme for behandling i casen

Rachmans (1977) sociale læringsteori og Pattersons coercion theory (1975) ligger til grund for forskning, der viser, at *reinforcing* af angst og trodsig adfærd, *modelindlæring* samt forældres *kontrol* har betydning for vedligeholdelsen af lidelserne angst og ODD. Med hensyn til reinforcement kan forældre forstærke barnets angste eller trodsige adfærd ved at belønne denne (positiv reinforcement) eller fjerne barnet fra den ubehagelige situation (negativ reinforcement) (Fisak & Grills-Taquechel, 2007). Særligt den negative reinforcement, hvor forældrene er eftergivende, trækker sig fra konflikter og ikke følger deres krav til dørs har betydning for vedligeholdelsen af trodsig adfærd hos barnet (Barkley, 2013). Når forældre trækker sig fra en eskalierende konflikt med barnet, der udviser

en aggressiv eller undgående adfærd, lærer barnet, at det med denne adfærd kan undgå at leve op til krav, barnet ikke gider eller er bange for. Et angst barn vil opleve en høj grad af motivation for at undgå angstfyldte situationer og kan derfor ty til aggressiv adfærd for at undgå disse. Forældres brug af inkonsistent disciplinering og eftergivenhed kan derfor også resultere i højnede angstniveauer, da det skaber uforudsigelighed for barnet (Granic, 2014).

Modelindlæring kommer til udtryk ved, at børn lærer af deres forældre ved at observere og lytte til dem (McLeod et al., 2011). Når forældre opmuntrer til undgåelse, vil barnet opfatte situationen som truende og imitere forældrenes undgåelsesadfærd. Forskning viser, at det samme gælder aggressiv adfærd, hvor barnet også vil imitere denne type adfærd udvist af forældre. Både angste og aggressive børn tolker tvetydige situationer som truende og vælger enten at benytte undgående eller aggressiv adfærd for at håndtere truslen (Barrett et al., 1996). Samtidigt har forældres grad af kontrol over barnet også betydning for barnets angst (McLeod et al., 2007). Når forældre er overinvolverede, signalerer de til barnet, at det ikke selv kan klare situationen og behøver hjælp. Barnet lærer derfor ikke at gøre sine egne erfaringer og forbliver uselvstændigt (McLeod et al., 2011). Samtidig ses ved ODD, at forældre gennem straf, kritik og hård disciplin forsøger at kontrollere deres børns adfærd, hvilket også forhindrer barnets udvikling af selvstændighed. Forskning tyder på, at overinvolvering ikke er unikt for

angstlidelser, men også ses ved ODD (Gere et al., 2012). Det er derfor muligt, at overinvolvering kan vedligeholde komorbiditeten mellem angst og ODD.

Casekontekst og metode

Artiklen beskriver Max og hans familie, der har modtaget individuel kognitiv adfærdsterapi (KAT) i en specialiseret angstklinik. Netop denne terapi blev valgt som behandling, da der er evidens for, at KAT er virksomt til angst (Weems & Varela, 2011). Samtidig gav individuel KAT mulighed for at arbejde med familiens dynamik grundet Max' ODD. Max er en eksemplarisk case for andre børn med angst og ODD, som henvender sig til klinikken, og casen muliggør en undersøgelse af forældrenes rolle i denne komorbiditet.

Metode og dataindsamling

Familien har givet informeret skriftligt samtykke til, at deres oplysninger må anvendes i forskningsmæssig sammenhæng og offentliggøres, så længe de er anonymiseret i henhold til persondataloven. De udfyldte spørgeskemaer og deltog i diagnostisk interview som led i undersøgelsen. Information om casen stammer fra henvendelseskema, udtalelse fra PPR, nedenstående skemaer, interview og observation, journalnotater samt videooptagelser af test og terapi.

Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS; for dansk version se Esbjørn, Sømhovd, Turnstedt & Reinholdt-Dunne, 2012) måler symptomniveau af angst og depression baseret på DSM-IV og indeholder 47 spørgsmål,

som besvares af både forældre (RCADS-p) og barnet (RCADS-c).

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997) er en kort screening til forældre på 25 spørgsmål om adfærd hos børn mellem 4-16 år. SDQ giver et indblik i barnets emotionelle, adfærdsmæssige og opmærksomhedsmæssige problemer, relationer med jævnaldrende og social adfærd.

Egna Minnen Beträffande Uppfostran (EMBU; Young et al., 2012) er et skema på 40 spørgsmål, som måler forældreadfærd gennem forældres (EMBU-p og barnets (EMBU-c) rapportering.

Anxiety Disorders Interview Schedule child/parent (ADIS-c/p; Silverman & Albano, 1996), er et semistruktureret interview, der måler symptomer på angst og andre lidelser (f.eks. ODD) beskrevet i DSM-IV. Symptomer med et kliniske funktionsforstyrrelsesniveau (CSR) på 4 eller over på en skala fra 0-8 indikerer klinisk lidelse. Barnet og forældre interviewes hver for sig, og information samles til fælles diagnosticering.

Tangram Task (TT; Hudson & Rapee, 2001) er en puslespilsopgave, som barnet udfører med hhv. mor og far. Opgaven viser interaktionen mellem forældre og barn vedrørende forældres negativitet og overinvolvering.

Klienten

Max, en etnisk dansk dreng på 9 år, bor med sin mor, far og lillesøster i en kommune præget af social slagside. Forældrene er omkring 40 år. Far arbejder i det private erhverv og har en mellemlang praktisk uddannelse. Mor går ledig, men har en mellemlang vide-

regående uddannelse. Hverken mor eller far har eller har haft psykiske vanskeligheder.

Forældrene beskriver, at Max har haft vanskeligheder, siden han var helt lille, men at det er blevet værre efter skolestart. Et par år tidligere har de haft kontakt med psykolog pga. Max' tiltagende angst og tvangsprægede handlinger. Psykologen henviser til børnepsykiatrien, der vurderer, at Max har emotionelle problemer og mangler opmærksomhed, omsorg og struktur, hvorfor han reagerer med vrede. Familien anbefales familiebehandling, men forældrene afslår grundet uenighed i vurderingen af Max. Han udredes senere af PPR, da skolen oplever, at han er trist. Det konkluderes, at Max har behov for angstbehandling. Det påpeges, at forældrene bør medvirke som aktiv part, da de vedligeholder angsten via særbehandling for at undgå vredesudbrud.

Familiens problemer, mål og styrker

Max er en normalbegavet dreng med en stærk viljestyrke. Han ser sine venner flere gange om ugen uden for skolen og går til flere fritidsaktiviteter. Han opfylder før behandling kriterierne for generaliseret angst (CSR= 6) og ODD (CSR=5). Max rapporterer selv om flere bekymringer, som er svære for ham at stoppe, bl.a. om han eller hans forældre kunne blive smittet med en sygdom og dø, samt om en tyv kunne komme ind i hans hjem og skade ham. Bekymringerne fylder særligt ved sengetid, så Max har svært ved at sove. Han føler derfor ikke, at han kan slappe af, han bliver nervøs og har svært ved at koncentrere sig. Bekymringerne

forstyrrer både hjemme og i skolen. Spørgeskemaet RCADS-c peger på social fobi og depression om end i lille grad. En forklaring på Max' lave rapportering er, at han er trodsigt afvisende overfor spørgsmål til egne problemer.

Forældrene rapporterer, at Max aktuelt har mange bekymringer om, hvorvidt der kommer tyve, om man kan blive skudt, hvad der sker, når man dør, krig og flygtningestrøm, at komme for sent og om at blive syg. Max tør derfor bl.a. ikke gå på WC alene. Max' bekymringer har været et problem i ca. 3 år. Forældrene oplever, at Max er meget udadreagerende hjemme. Han bliver ofte vred, nægter at gøre, hvad han har fået besked på, mister besindelsen, skændes med voksne, taler grimt til sine forældre, lyver for at undgå negative konsekvenser og accepterer ikke et nej fra forældrene. Forældrene fortæller, at det altid har været sådan, og det udmønter sig i daglige skænderier i hjemmet. Spørgeskemaet RCADS-p peger på social fobi, depression, separationsangst, OCD og generaliseret angst. SDQ tyder på en meget høj grad af emotionelle symptomer, høj grad af adfærdsproblemer og lav grad af prosocial adfærd. Disse vanskeligheder har meget høj grad af negativ påvirkning på Max' liv.

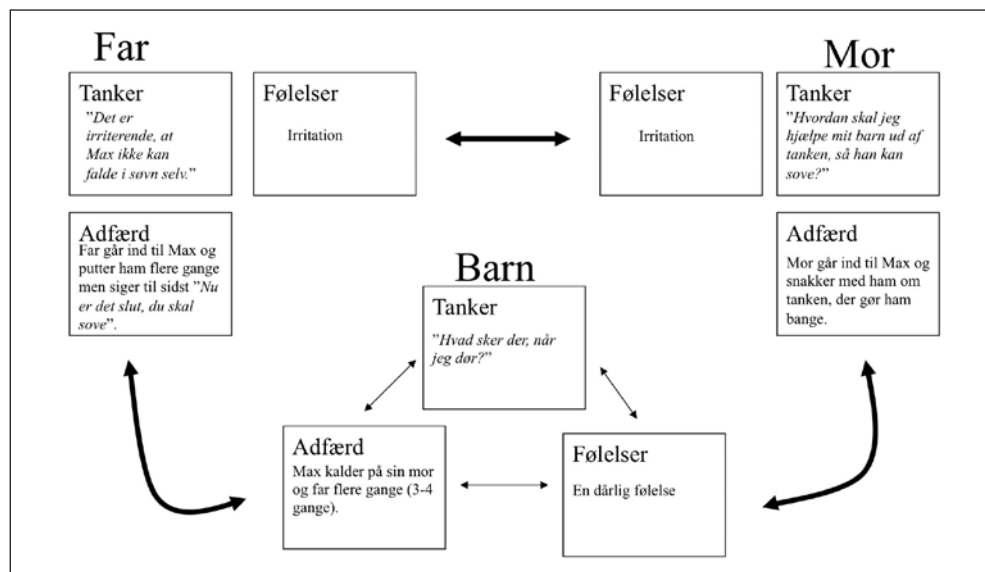
Data vedrørende forældreadfærd målt på både Max' og forældrenes besvarelse af spørgeskemaet EMBU viser, at forældrene udviser lav grad af afvisning, høj grad af emotionel varme og overbeskyttende og kontrollerende adfærd med en moderat grad af angst-

præget opdragelse. Observation af forældre-barn interaktionen med TT er præget af høj grad af overinvolvering. Både mor og far giver Max for mange instruktioner, mere hjælp end nødvendigt og tager over, når han tøver. Interaktionen mellem far og Max er også præget af negativitet og fjendtlighed. Far er anspændt og utålmodig. Max reagerer ved at sige "*Du er simpelthen så dårlig*", når far prøver at hjælpe, hvorefter han ødelægger puslespillet, far har lavet. Interaktionen mellem mor og Max er mere positiv og varm. De smiler undervejs. Mor roser og opmuntrer Max ved at sige "*godt udgangspunkt, det er godt tænkt synes jeg*", også selvom Max giver hurtigt op. Når de lykkes med opgaven, er de glade og giver hinanden high-five.

Caseformulering og behandlingsplan

I første familiesession laves en caseformulering, hvor Max og forældre fortæller deres tanker, følelser og adfærd om den situation, at det er aften og Max skal sove. Den viser hvordan Max, mor og far påvirker hinanden gensidigt.

Mor går ind til Max og taler med ham om hans angst. Far putter igen og igen, men bliver frustreret. Max får altså både mor og far til at komme, når han kalder. Forældrene kommer derved til at vedligeholde Max' angst. De forstærker hans undgåelse ved at komme, når han kalder og blive hos ham, hvorfor han ikke lærer at håndtere sine følelser på egen hånd. Samtidig bliver både Max' far og mor irriterede, og de har svært ved at sætte klare grænser og bliver derfor eftergivende, hvilket vedligeholder Max' trods.



Figur 1 Caseformulering for Max og forældre

Behandlingsplan

Forældrenes fortællinger, kombineret med tidligere undersøgelsers påpegnelse af behov for angstbehandling fører til, at der tilrettelægges et angstbehandlingsforløb med få forældresamtaler. Der fokuseres i denne planlægning ikke på trodsproblematikken, da det er almindeligt at trods kan forekomme som en sekundær problematik til angst, der går i sig selv når angsten behandles.

Efter familiesamtalen opstilles familiens mål for behandlingen, som strukturerer dennes forløb: 1) at Max har færre bekymringer, når han skal sove. 2) at Max ikke er bange, når det er mørkt – både indenfor og udenfor. 3) at Max selv kan gå på toilettet. 4) at Max bliver mindre vred og opfører sig ordentligt. 5) at Max kan klare sig selv om aftenen f.eks. selv gå på toilet, selv tage vand osv. Som nævnt var planen er at arbejde med Max' angst, fordi

denne i familiens fortællinger udgjorde det primære problem. Undervejs i forløbet bliver det dog tydeligt, at Max' trods står i vejen for dette, hvorfor indholdet i behandlingsforløbet tilpasses, og der sættes ind overfor trodsen. Da der var tale om behandling i en forskningsklinik, var det ikke muligt grundlæggende at ændre på strukturen i forløbet, hvilket kan være medvirkende til at forløbet ikke blev optimalt. Ikke desto mindre, vil denne begrænsning i mulighederne for at tilføje yderligere samtaler være en reel problematik i samme sammenhænge i kommunale praksisser, hvorfor forløbet kan illustrere de vanskeligheder der kan opstå i denne type situationer. De elementer der indgår i behandlingen baserer sig dels på principper fra KAT-baseret angstbehandling og dels fra KAT-baseret trodsbehandling. Psykologen gennemfører følgende elementer i behandlingen:

Elementer	Indhold
Belønninger	Det er nødvendigt at motivere Max, da han udviser modstand og trods fra starten. Der anvendes belønninger og ros, når Max deltager. Forældrene opfordres til også at bruge belønning.
Psykoedukation	Max introduceres til hvad angst er, hvordan angst føles i kroppen og at tanker og adfærd hænger sammen. Forældrene introduceres til hvordan de vedligeholder angst ved at tillade undgåelse og trods ved ikke at være konsekvente og tydelige i deres grænsesætning.
Følelser og tanker	Max lærer at identificere og kontrollere følelser gennem afslapningsteknikker og udskydelse af følelsen. Bekymringstanker identificeres og udfordres via kognitiv omstrukturering, hvor hjælpetanker findes. Derudover skrives bekymringer og vrede tanker ned og lægges i en bekymrings- og en vredeskasse.
Kontrolantagelser	Max introduceres for begrebet kontrol, ved for eksempel at børn kan have en oplevelse af, at kontrollen over deres egne tanker og følelser ligger uden for dem selv (f.eks. hos forældre), eller at de selv har kontrol over dem. I efterfølgende sessioner opfordres Max til at forsøge at tage kontrol over sine følelser og adfærd.
Ekspone- ring	Max lærer at håndtere det, han er bange for, ved at blive i situationen indtil angsten falder. Den gradvise eksponering foretages i sessionerne og hjemme.
Assertiv adfærd	Max lærer om forskellige typer af adfærd; passiv, aggressiv og assertiv. Han øver at bruge assertiv adfærd hjemme – at være et sejt barn.
Problem- løsning	Max introduceres til problemløsning, hvor mulige løsninger og konsekvenser opstilles, så han lettere kan vælge løsning når han oplever problemer.

Terapiforløbet

Forløbet består af en indledende og afsluttende familiesamtale, 10 børnesessioner og 2 forældresessioner på hver 45 minutter. Beskrivelserne bygger på psykologens journalnotater og videooptagelser af sessionerne.

1. familiesession

Sessionen består af præsentation af forløbet, udarbejdelse af mål, caseformulering, introduktion til angst og uartig adfærd samt brug af belønning

ger som motivation. Max viser modstand mod at deltage. Han hører ikke efter og siger, at han ikke gider være der. Ifølge forældrene lyver han, når han siger, at hans angst er gået væk. Han lægger sig flere gange henover bordet og lukker øjnene. Han følger dog psykologens instruktion om at sætte sig ordentligt. Max bliver sur, når mor fortæller, hvad han er bange for, og hvordan han reagerer. F.eks. siger Max *“det passer ikke”* når mor fortæller, at han ikke kan sove om

aftenen pga. bekymringer. Når psykologen taler til forældrene, begynder Max at tromme i bordet, kradse sig hårdt på kinden og lave lyde. Far nusser Max på ryggen, når forældrene taler til ham. Far deltager ikke i lige så høj grad som mor i sessionen, og det er mor, der irettesætter Max undervejs. Når hun gør dette, eskaleres hans trodsige adfærd, hvorefter hun trækker sig og ikke følger sine krav igenem. Som eksempel:

Mor: *"Ikke mere brok, jeg vil ikke høre mere på det, jeg har ikke lyst til at høre mere på det. Slut!"*

Max: *"Jamen det bliver sådan her hele dagen."*

Mor: *"Nej det kan ikke hjælpe noget."*

Max: *"Jo det gør"*

Selvom mor forsøger at sige stop, fortsætter Max med at udtrykke modstand ved f.eks. at slå hovedet ned i bordet. Mor bryder derudover ind flere gange og fortæller om Max' problemer på vegne af Max, fordi Max lyver og siger, at han ingen problemer har. Max siger flere gange, at han ikke vil komme næste gang, og at han vil løbe væk fra sin mor, når de skal af sted. Til sidst laver Max og psykologen en aftale, om at han skal komme.

Bornesession 1-3: Psykoedukation og følelsesarbejde

Sessionen består af psykoedukation om følelser som angst og vrede, introduktion til den kognitive model, afslapningsteknikker og følelsestermometer til at monitorere angst. I første session fortæller Max, at han ikke er så bange mere, men han rapporterer dog stadig om flere bekymringer undervejs i terapien, f.eks. om der kunne komme no-

gen og tage ham, når han skal sove. På en skala fra 0-10 mener Max, han har været bekymret på 6 i den foregående uge. Han har lavet hjemmearbejde, deltager og svarer på psykologens spørgsmål og siger, at han gerne vil arbejde på at få det bedre. I anden og tredje session har Max ikke lavet hjemmearbejde. Han giver udtryk for, at han ikke vil være i terapien, og at det ikke hjælper ham. Når psykologen siger, at det er forældrenes beslutning, at han går i klinikken, siger han, at hans forældre ikke bestemmer over ham. Han opfører sig trodsigt ved f.eks. at holde sig for ørene, lade som om han sover, tale grimt til psykologen og nægte at udfylde arbejdsark og svare på spørgsmål. I anden session siger Max, at han ikke vil komme næste gang og ikke vil lave hjemmearbejde, da det *"er til ingen verdens nytte."*

Psykologen følger nogle gange, men ikke konsekvent, sine krav til dørs ved f.eks. at fortælle det, hun har intentioner om, selvom Max protesterer. Da mor kommer ind, eskaleres Max' trodsige adfærd. Han vil f.eks. ikke blive siddende på stolen og ender til sidst med at sidde med ryggen til psykologen.

Mor er med til slut i alle tre sessioner. Mor og psykologen griner flere gange af Max' spydigheder, og giver ham dermed positiv opmærksomhed for den uartige adfærd. Samtidig nusser mor Max, når han bliver ked af det, efter hun har irettesat ham. Mor beder Max om at opføre sig ordentligt flere gange, men følger ikke kravet til dørs. Max nægter både i session 2 og 3 at sige farvel til psykologen, selvom mor og psy-

kologen siger, at han skal. Her forsøger mor at irettesætte ham, hvilket fremstår tvetydigt, da hun samtidigt kalder ham et kælenavn. Mor fortæller, at konflikter derhjemme ofte ender med, at forældre truer med eller rent faktisk tildeler en straf som f.eks. at fjerne iPad.

1. Forældresession

Sessionen består af introduktion til forskellen på angst og trodsig adfærd og vedligeholdelse af disse ved positiv forstærkning og mangel på tydelig og konsekvent grænsesætning. Psykologen inddrager egne observationer af forældrenes tvetydige irettesættelse af Max. Forældrene fortæller, at de ikke oplever forandringer i Max' adfærd, hvorfor de bekymrer sig om, om det er det rigtige at gå i det aktuelle terapi-forløb. Far giver udtryk for, at han har svært ved ikke at vise sin egen irritation i konflikter med Max.

Børnesession 4-5: Kognitiv omstrukturering

Sessionerne består af introduktion til kognitiv omstrukturering, angstkurven og principper for gradvis eksponering konkretiseret i sessionen gennem eksponering for at køre i elevator og være i mørke. I session 4 og 5 har Max lavet hjemmearbejde, hvilket han får ros og belønning for af psykologen. Max deltager i begge sessioner og giver udtryk for, at han gerne vil komme igen næste gang. Han fortæller, at han har fået det bedre og kun har været bekymret få gange. Han kan nu klare at være alene hjemme med sin lillesøster og selv køre i skole. Max udfører eksponeringsøvelserne i sessionen velvilligt,

får belønninger for det og oplever, hvordan angsten reduceres, når han bliver i situationen. I slutningen af session 4 roser mor Max for at have opført sig ordentligt og deltaget. Hun irettesætter ham en enkelt gang, men hun følger ikke til dørs og accepterer hurtigt en uartig adfærd. I session 5 er far med inde afslutningsvist. Max fortæller far, hvad han har lavet i dagens session, men far er tilbageholdende med ros. Både far og psykolog giver Max positiv opmærksomhed for sin trodsige adfærd ved at grine, når han er uopdragen.

Børnesession 6: Eksponering og kontrolantagelser

Sessionen består af præsentation af begrebet kontrol, og hvordan Max skal lære at tage kontrol over angst og vrede samt videre arbejde med eksponering og trappetiget træning. Mor efterspørger inden sessionens start en samtale med psykologen uden Max. Her fortæller hun, at Max' angst og trods har tiltaget i den foregående uge. Psykologen påpeger igen vigtigheden af at være vedholdende i grænsesætningen overfor Max. I session 6 vender Max' trodsige adfærd tilbage. Max har ikke udført hjemmearbejdet og giver udtryk for, at han ikke vil være i terapien. Psykologen gør ham opmærksom på, at han ligesom alle andre børn har ret til et godt børneliv, men det mener Max ikke selv, at han har. Max bliver dog en smule mere motiveret undervejs og følger efterhånden psykologens instruktioner. Afslutningsvist tegner Max sig selv som død på tavlen og siger, at han selv er dum. Han vil ikke deltage i mere af arbejdet, hvorfor psy-

kolog henter mor og gennemgår principperne for eksponering og trappesti-
getræning med hende. Når mor er inde
i lokalet i slutningen af sessionen, gri-
ner hun flere gange af Max' trodsige
adfærd, og hun blander sig i hans valg
af belønninger, uden at han efterspør-
ger hendes hjælp.

Børnesession 7-8: Repetition af de- tektivtænkning, eksponeringsprin- cipper og kontrolantagelser

Sessionerne består af repetition af
principperne bag detektivtænkning,
angstkurven og kontrol, introduktion
til bekymrings- og vredeskasse, ekspo-
nering for mørke og udarbejdning af en
trappestige for at kunne gå alene på sit
værelse i mørke. Til session 7 har Max
har ikke lavet hjemmearbejde. Max for-
tæller, at han nægter at gøre det, når
hans forældre beder ham om at øve sig
i at udfordre sin angst, hvilket gør hans
forældre sure på ham. Max giver ud-
tryk for, at han ikke ønsker at være i
terapien og er grænsesøgende ved f.eks.
at bøvse højt flere gange, nægte at
svare, at lade som om han sover og sige
grimme ord. Psykologen skal ofte gen-
tage instrukserne flere gange, før Max
formår at efterleve dem. Psykologen
fortsætter med at gentage og er vedhol-
dende, selvom han forsøger at få hende
til at stoppe. Efter noget tid hvor Max
ikke er samarbejdsvillig, forlader psy-
kologen lokalet og siger, det er fordi
han ikke hører efter, men at hun kom-
mer tilbage om lidt. Da hun kommer
ind igen, siger Max flere gange "*jeg er
dum*". Psykologen forsøger at udfordre
denne tanke. Max deltager herefter vel-
villigt. Da mor kommer ind i session 7,
fortæller hun, at den eneste belønning,

som Max har fået, ikke rigtig tæller.
Hun er generelt tilbageholdende med
ros, f.eks. da Max fortæller, at han i
sessionen har været oppe i et mørkt
rum alene. Hun siger, at hun derhjem-
me ikke kan få ham til at gøre det, hun
beder ham om. Mor svarer desuden på
psykologens spørgsmål henvendt til
Max, uden at Max kan nå at svare. Mor
fortæller, at de benytter straf hjemme
f.eks. ved at give Max mere lektietid,
hvilket Max ikke synes virker på at
mindske hans vrede. Psykologen intro-
ducerer derfor Max og mor for brugen
af 3 advarsler, hvis Max ikke opfører
sig ordentligt, hvor 3. advarsel skal
medføre, at "blive sendt på værelset". I
session 8 deltager Max velvilligt og gør,
hvad han får besked på. Han har lavet
hjemmearbejde og kan nu selv gå rundt
i sit hus i mørke. Max vurderer, at han
har det bedre og ikke har været bange
siden session 7.

Børnesession 9: Problemløsning og assertiv adfærd

Sessionen består af præsentation af
problemløsning og assertiv adfærd,
gennemgang af Max' mål for behand-
lingen og eksponering for at låne ting
af personer, Max ikke kender. Max op-
lever, at han kun har været en lille
smule bange siden sidst. Max mener,
at han har opnået langt de fleste mål,
men han oplever fortsat, at han har
svært ved at kontrollere sin vrede. Han
har lavet hjemmearbejde og får beløn-
ninger for at øve sig på at være mindre
vred og gøre, hvad forældrene siger.
Max er træt og har i begyndelsen af
sessionen vanskeligt ved at deltage.
Hen imod slutningen deltager han dog
og gør, hvad psykologen beder ham om.

2. forældresession

Sessionen består af en tilbagemelding på forløbet, gennemgang af tillærte teknikker som eksponering, vedholdenhed og belønning samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. Forældrene fortæller, at de oplever en markant forandring i Max' adfærd, hvor han klarer langt flere ting end tidligere, ikke fremstår ængstelig og er gladere. De har fået positive tilbagemeldinger fra skolen. De fortæller, at Max er blevet bedre til at få nedreguleret sin vrede. De oplever dog, at Max fortsat har mange konflikter med sin lillesøster og har svært ved at efterleve deres retningslinjer. De fortæller, at de bruger advarsler og "at blive sendt på værelset". Mor og far beskriver, at de før nok har hjulpet Max for meget med ting, han godt selv har kunnet klare. Far fortæller, at han selv kan blive vred, inden konflikten er startet, fordi han forventer, at det helt sikkert alligevel vil ende i at eskalere. Det vil han prøve at mindske.

Børnesession 10: eksponering og afslutning

Sessionen består af fejring af fremskridt, introduktion til selvbelønning, eksponering for mørke og at køre i elevator, tilbageblik på øvelser og angstniveauer og forebyggelse af tilbagefald. Max fortæller, at han slet ikke har været bekymret siden sidste session. Han synes, det går bedre med ikke at blive for vred overfor lillesøster og at gøre, hvad hans forældre siger. Han deltager aktivt i sessionen og gør, hvad der bliver sagt. Han vil stadig gerne øve sig på at være mindre vred.

Da mor kommer ind, er Max i gang med at samle en legofigur og beder hende om hjælp. Mor tager helt over og retter det samlearbejde, Max allerede har lavet. Derudover er stemning mellem Max og mor positiv.

Afsluttende familiesamtale

Sessionen består af tilbagemelding fra familien på forløbet, gennemgang af behandlingsmålene, udarbejdning af en tilbagefaldsplan med fokus på, hvad der har virket bedst i forløbet og udlevering af diplom til Max. Familien fortæller, at Max mestrer de ting, der tidligere har været udfordrende og har opnået behandlingens mål. Max har lavet sit hjemmearbejde, og han har fået belønning for sin modige adfærd. Under sessionen udviser Max dog trodsig adfærd. Han har svært ved at høre efter og taler grimt til begge forældre. Han virker dog glad og formår nogle gange men efter gentagelser at gøre, det han bliver bedt om. Mor svarer på psykologens spørgsmål, der er henvendt til Max. Far nusser ham på øret og i håret, når han bliver irriteret på ham. Han nusser ham også, når moren prøver at irettesætte ham.

Analyse af forældrenes adfærd i sessionerne

Modelindlæring

Undervejs i forløbet giver far udtryk for, at han hurtigt bliver irriteret på Max. Nogle gange bliver han vred på Max inden konflikten er startet, fordi han forventer, at Max eskalerer sin trodsige adfærd. Denne adfærd lærer Max derfor gennem modelindlæring er brugbar i konflikter. Ved anden forældresession siger far, at han vil forsøge

at mindske denne adfærd, men da han først italesætter dette her, er det usikkert, hvor stor en effekt det kan nå at få ift. forbedringen af Max' adfærd umiddelbart efter behandling. Samtidig fortæller begge forældre, hvordan de har tilpasset deres liv til Max' angst og vedligeholdt hans undgåelsesadfærd. Mor udtrykker flere gange i forløbet, at hun selv er ængstelig for flere ting, som Max også er angst for og holder sig fra disse. Dette kan føre til modelindlæring af undgåelse hos Max. At forældrene i start af forløbet opmuntrer Max til undgåelse skaber en tro i Max på, at han ikke kan håndtere angstprovokerende situationer. Under forløbet psykoedukerer psykologen om betydningen af undgåelse samt principperne bag eksponering. Samtidig bliver forældrene informeret om, hvordan de kan blive bedre til at skubbe Max ud i udfordringer og fremme hans selvstændighed. Efter dette mindskes forældrenes modellering af undgåelse.

Reinforcing

Forældrene reforcerer Max' negative adfærd positivt f.eks. ved at grine, når han er uopdragen og være kærlige/nusse/kalde ham kælenavne, når han irettesættes. Forældrene sender tvetydige signaler, så disciplinering bliver inkonsistent. Dette påtåles ved første forældresession, og adfærden mindskes en smule. Det skal påpeges, at også psykologen kommer til at anvende positive reinforcing ved at grine af Max' uartige adfærd. Undervejs i forløbet får Max belønninger af både psykologen og forældrene for modig og prosocial adfærd, hvilket virker motiverende for ham, så den positive reinforcing flyt-

tes fra den uønskede til den ønskede adfærd. Særligt i begyndelsen af forløbet ses flere gange, hvordan forældrene ikke følger deres krav til dørs og dermed negativt reforcerer Max' trodsige adfærd. F.eks. nægter Max at lave sit hjemmearbejde. Max lærer derved, at han gennem sin trodsige adfærd kan slippe for at følge anvisninger. Dette fastholder Max i hans trodsige og hans angste adfærd, hvorfor vigtigheden af at forældrenes vedholdenhed tydeliggøres i første forældresession af psykologen. Dette synes efter nogle sessioner at guide forældrene til mindre ændring i anvendelse af reinforcing. Samtidig benytter både Max og forældrene trusler som forsøg på at få den anden til at give sig. Trusler er dog ikke hensigtsmæssige, men eskalerer derimod konfliktniveauet (Barkley, 2013). Psykologen får ikke påtalt vigtigheden af at undlade brug af trusler.

Overinvolvering/overkontrol

Der ses i slutningen af forløbet, at forældrene stadig kan være overinvolverede f.eks. at mor kan have en tendens til at "tage over" for Max ved at svare på spørgsmål rettet til ham eller vælge belønninger for ham. Forældrene er dog lidt bedre til at fremme hans selvstændighed ved at støtte ham i at gennemføre udfordringer og lade ham lære af sine egne erfaringer. De fortæller også, at Max er blevet bedre til at tage kontrol over sine følelser, hvilket kan skyldes hans større grad af selvstændighedsfølelse, hvor han ikke behøver forældrenes hjælp.

Terapimonitorering og brug af feedback information

Psykologen anvender som nævnt informationer fra Max og familien til at tilpasse behandlingen, så også trodsen behandles. Yderligere skabes motivation hos Max med belønninger, når han ikke vil lave hjemmearbejde eller deltage. Når forældrene giver udtryk for, at de ikke oplever bedring gennemgår psykologen principperne for vedligeholdelse af angst og trods. Forældrene syntes at have gavn af dette, og ved anden forældresession giver de udtryk for, at Max er mindre ængstelig og trodsig. Forældrene og Max fortæller ved sidste familiesession, at Max har opnået alle sine mål for behandlingen – dette på trods af, at Max igen udviser høj grad af trodsig adfærd i sessionen. Generelt ses dog ved slutningen af forløbet stadig elementer i forældrenes adfærd (overinvolvering, negativ reinforcement og modelindlæring), som kan vedligeholde både Max' angst og ODD. Disse elementer ses til dels også hos psykologen, som positivt og negativt reforcerer Max' ODD.

Konkluderende evaluering af terapiprocessen og outcome

Interview med både forældre og Max efter behandling viser, at Max ikke har en klinisk angstlidelse eller ODD længere. Samtidig giver forældrene udtryk for, at de oplever en markant forbedring i Max' humør, og at han nu selvstændigt mestrer langt flere situationer end tidligere. RCADS udfyldt af mor og Max efter behandling indikerer, at Max ikke længere lider af angst. RCADS udfyldt af far indikerer dog social fobi, depression og generaliseret

angst, dog på et lavere niveau end før behandling. At farens rapportering adskiller sig, kan skyldes, at far ikke har været lige så involveret i behandlingen som mor og derfor ikke har bemærket ændringer i samme omfang. I de kvalitative observationer af både børne- og forældresessioner ses, at Max er blevet mere selvstændig og bedre til at udfordre sig selv. I børne- og forældresessionerne ses, at mor bliver bedre til at rose Max for at gøre modige ting. Mod slutningen af forløbet, ses at Max' trodsige adfærd overfor psykologen er mindsket og konflikterne mellem Max og forældrene forkortet. Mor bliver bedre til at irettesætte ham konsekvent, men kun i nogle tilfælde og hen imod slutningen af forløbet er der stadig tilfælde, hvor mor ikke følger sine krav til dørs. Hun forekommer fortsat noget overinvolveret, f.eks. da hun forsøger at vælge belønning for Max. Dog vender hans trodsige adfærd tilbage i den sidste familiesession, og forældrene synes ikke at reagere anderledes på denne, end de gjorde ved første familiesession, idet begge forældre stadig giver Max positiv opmærksomhed på trodsig adfærd.

Diskussion

De kvantitative mål og de kvalitative observationer af adfærd viser, at forældrenes adfærd ikke er signifikant forandret efter behandling. Dette kan muligvis forklare, hvorfor Max stadig ved sidste session udviser høj grad af trodsig adfærd. Den generelle mangel på forandring i forældrenes adfærd kan skyldes, at psykologen ikke har adresseret den problematiske adfærd tilstrækkeligt, når den kom til udtryk i

terapien. Psykologen har fortalt forældrene om, hvordan de skal håndtere den trodsige og angste adfærd, men når forældrene i selve sessionerne udviser den vedligeholdende adfærd, adresseres denne *ikke* af psykologen. Max oplever bedring i sin angst, selvom forældrene ikke har ændret adfærd. Dette kan undre, da forældrenes adfærd er associeret med barnets angst (McLeod et al., 2011). Dog kan bedringen skyldes andre faktorer herunder psykologens direkte arbejde med Max' angst blandt andet med eksponering og øvelser, der har vist Max, at han kan håndtere sin angst selv. Forældrene har ikke i tilstrækkelig grad lært at tage over fra psykologen og gennemføre behandlingsprincipperne i hjemmet. Dette kan være problematisk, da forskning har vist, at overdragelse af kontrol til forældre kan vedligeholde barnets bedring over tid (Manassis, et al., 2014). Fordi Max fortsat er trodsig overfor forældrene, og fordi der ses minimale forandringer i forældrenes adfærd, kan man derfor være i tvivl om, hvorvidt Max' bedring kan vedligeholdes efter behandlingen.

Styrker og svagheder

Studiet har flere begrænsninger. For det første mangler vi et kvantitativt mål til at vurdere trodssymptomer efter behandling. Fravær af opfølgningsdata betyder, at vi ikke ved om Max' bedring er vedvarende, og hvilken rolle manglen på forandring af forældrenes adfærd kan spille. For det andet mangler kvantitative mål på flere af de forældrefaktorer, der er knyttet til angst og ODD, herunder mål af reinforcement. Dog belyses denne form for foræl-

drefaktor gennem kvalitative observationer. For det tredje kan man kritisere artiklen for ikke at inkludere alle de øvrige faktorer, der spiller ind på børns udvikling, som kunne have kastet yderligere lys over artiklens fund. På trods af disse svagheder kan studiet bidrage med praktisk viden om, hvordan forældre kan påvirke barnets angst og ODD, og hvilke udfordringer der kan opstå i behandling i lyset af dette.

Fremtidige implikationer for behandling

Selvom flere studier ikke viser en mereffekt ved inddragelse af forældre i behandling af angst hos børn, kan forældreinddragelse være væsentlig i behandling af ODD. Casestudiets fund understøtter pointen om, at forældreinddragelse også kan være vigtig ved komorbid ODD i angstbehandling. Studiet rejser væsentlige implikationer for planlægning af forældreinddragelse i behandling. Den første vedrører hvor meget tid, der sættes af til at arbejde direkte med forældre, når man ønsker at ændre deres adfærd overfor barnet. Denne pointe kan synes særligt væsentlig i behandling med KAT, som ofte består af relativt få sessioner sammenlignet med andre terapiformer. Vores studie tyder på, at det kræver mere end de to forældresessioner, der var indlagt i behandlingen, når barnet har komorbid angst og ODD. Den anden implikation vedrører, i hvilken udstrækning psykologen formår at anvende alle muligheder for at påvirke forældre og barn i den ønskede retning. I sessionerne ses til tider, at forældrene anvender vedligeholdende adfærd, men psykologen formår ikke at udnytte tilstrækkeligt af disse muligheder til

at påpege problematikken og dermed påvirke adfærden i ønsket retning. Dette syntes særligt væsentligt i KAT, da antallet af forældresessioner ofte er begrænset. Studiets fund understreger vigtigheden af, at psykolog er opmærksom på og benytter de lejligheder, der byder sig i terapien til at påpege den problematiske adfærd både fra barnets og forældrenes side. Som vi også så i casen, bliver det vigtigt, at psykologen er opmærksom på at agere rollemodel for forældrene i dette arbejde. Dels for ikke selv at vedligeholde problematikken, og dels fordi det er lettere for forældre at kopiere hensigtsmæssig adfærd end selv at identificere hvilke elementer denne adfærd består af og initiere disse.

Casestudiet illustrerer, hvordan psykologen kommer til at vedligeholde problematikken, og hvordan en kompleks sag kan vanskeliggøre psykologens arbejde. Vi ser, hvordan kompleksiteten gør det svært for psykologen at strukturere og følge op på de igangsatte behandlingstiltag. Tæt supervision på baggrund af videooptagelserne af sessionerne ville formodentlig i højere grad end supervision på baggrund af noter kunne have støttet psykologen i behandlingsopgaven så færre interventionsmuligheder overses og ikke benyttes. Dette kan syntes særligt vigtigt, når psykologen er ny i faget. Videosupervision med en erfaren supervisor kan sikre, at praksisnær viden deles, hvilket kan konkretisere interventionsmulighederne og derved fremme psykologens faglighed og selv-sikkerhed som terapeut.

Referencer

- Angold, A., Costello, E. J., & Erkanli, A. (1999). Comorbidity. *Journal of child psychology and psychiatry*, 40(01), 57-87.
- Barkley, R. A. (2013). *Defiant children: A clinician's manual for assessment and parent training*. Guilford Press. Pp. 1-86.
- Barrett, P. M., Rapee, R. M., Dadds, M. M., & Ryan, S. M. (1996). Family enhancement of cognitive style in anxious and aggressive children. *Journal of abnormal child psychology*, 24(2), 187-203.
- Breinholst, S., Esbjørn, B. H., Reinholdt-Dunne, M. L., & Stallard, P. (2012). CBT for the treatment of child anxiety disorders: A review of why parental involvement has not enhanced outcomes. *Journal of Anxiety Disorders*, 26(3), 416-424.
- Esbjørn BH, Sømhovd MJ, Turnstedt C, Reinholdt-Dunne ML (2012) Assessing the Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) in a National Sample of Danish Youth Aged 8–16 Years. *PLoS ONE* 7(5): e37339
- Fisak Jr, B., & Grills-Taquechel, A. E. (2007). Parental modeling, reinforcement, and information transfer: risk factors in the development of child anxiety?. *Clinical child and family psychology review*, 10(3), 213-231.
- Gere, M. K., Villabø, M. A., Torgersen, S., & Kendall, P. C. (2012). Overprotective parenting and child anxiety: The role of co-occurring child behavior problems. *Journal of anxiety disorders*, 26(6), 642-649.
- Granic, I. (2014). The role of anxiety in the development, maintenance, and treatment of childhood aggression. *Development and psychopathology*, 26(4pt2), 1515-1530.
- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. *Journal of child psychology and psychiatry*, 38(5), 581-586.
- Hood, B. S., Elrod, M. G., & DeWine, D. B. (2015). Treatment of Childhood Oppositional Defiant Disorder. *Current Treatment Options in Pediatrics*, 1(2), 155-167.
- Hudson, J. L., & Rapee, R. M. (2001). Parent-child interactions and anxiety disorders: An observational study. *Behaviour research and therapy*, 39(12), 1411-1427.
- Kendall, P. C., Brady, E. U., & Verduin, T. L. (2001). Comorbidity in childhood anxiety disorders and treatment outcome. *Journal*

- of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(7), 787-794.
- Manassis, K., Lee, T. C., Bennett, K., Zhao, X. Y., Mendlowitz, S., Duda, S., ... & Bodden, D. (2014). Types of parental involvement in CBT with anxious youth: A preliminary meta-analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol 82(6), 1163-1172.
- McLeod, B.D., Wood, J.J., & Avny, S.B. (2011). Parenting and Child Anxiety Disorders. In McKay & Storch (2011): *Handbook of Child and Adolescent Anxiety Disorders*. Pp. 213-228. Springer.
- McLeod, B. D., Wood, J. J., & Weisz, J. R. (2007). Examining the association between parenting and childhood anxiety: A meta-analysis. *Clinical psychology review*, 27(2), 155-172.
- Patterson, G. R. (1975). *Families: Applications of social learning to family life*. Champaign, IL: Research Press.
- Rachman, S. (1977). Conditioning theory of fear-acquisition – critical-examination. *Behaviour Research and Therapy*, 15, 375–387.
- Silverman, W. K., & Albano, A. M. (1996). *Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV.: Parent/Child interview schedule*. Oxford University Press.
- Weems, C. F. & Varela, R. E. (2011). Generalized Anxiety Disorder. In McKay, D., & Storch, E. A. (Eds.). (2011). *Handbook of child and adolescent anxiety disorders*. Springer Science & Business Media. ss. 261-274.
- Young, B. J., Wallace, D. P., Imig, M., Borgerding, L., Brown-Jacobsen, A. M., & Whiteside, S. P. (2012). Parenting behaviors and childhood anxiety: A psychometric investigation of the EMBU-C. *Journal of Child and Family Studies*, 22(8), 1138-1146.